

modem: WD87372864D92
Vmid: H369054274140

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J366921841720

ANA JUSTINA DE AQUINO MATEUS

IDADE: 63a	PESO: 57	ALTURA: 153	PROFISSÃO:
SINTOMAS:			
QUEIXAS: Ronco			
MEDICAMENTOS: Rosuvastatina; ^{SIN} lincil; Fluoxetina; Sulpina Quom.			
MÉDICO: Dr. Camilo			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: Pivates			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 00:00		HORA QUE ACORDA: 9hs	
COCHILO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO			
FUMO () SIM () NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: OX	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 18.7	SPO2: 86%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: * Sínd Pânico *			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não		IMC:	
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
16/07 Avaliação			
24 msc Pico Pico			
24/07 P = 7.9 cmH ₂ O			
24 m. de uso: 6h 12'			
Fuga = 3min			
IAH = 4.1 e/ev fua			
09/08 P = 7.4 cmH ₂ O			
24 IAH = 4 e/ev			
m de uso: 6h 7'			
fuga: 1m			
Relata sentir-se superada			
Orienta diário de sono			
30/08/24 P = 7.9 cmH ₂ O			
IAH = 4.7 e/ev			
m uso = 5h 57'			
Bem adaptada Silvia			
19/11 P = 7.9 cmH ₂ O			
24 IAH = 4.1 e/ev			
m de uso: 6h 13'			
fuga: 0			
Bem adaptada Natasha			



CLÍNICA **OPUS**

OTORRINOLARINGOLOGIA
E ESPECIALIDADES

Indicado CTAP para -
paciente an-gustia de
Aguirre Matam, com
grato de SADS noturna,
AET: 18,2 / hora.

16/07/24
Dra Camila C. Passos Dall'Oca
Crm 125.477 RQE 35183

www.clinicaopus.com.br

Rua Jd Nova América:
Rua Fernão Dias, 340 - Jd. Esplanada
P: 12242-580 - São José dos Campos-SP

Alergia e Imunologia
Cirurgia Plástica da Face
Endocrinologia
Endocrinologia Pediátrica
Fonoaudiologia
Otorrinolaringologia
Urologia

Pronto Atendimento Otorrino

Nome: ANA JUSTINA DE AQUINO MATEUS
Data de Nascimento: 5-7-1961
IMC: 28,62
Sexo: Feminino
Data do exame: 04-06-2024

Peso: 67 kg
Altura: 1,53 m
Médico: DRA. CAMILA CARRARA
YASSUDA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 565,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 151,0 e 165,0 minutos. O tempo total de sono foi de 353,0 min, eficiência de 62,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 62,3%; estágio N3: 12,7%; sono REM: 21,8%. O índice de despertares foi de 10,8/hora (normal < 10/h).

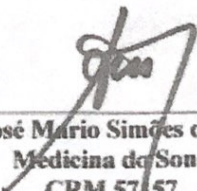
O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,7/hora, sendo 8 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 80 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 86%, permanecendo 0,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 62 - 82 bpm e NREM de 59 - 81 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 18,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=86%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (10,9/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.
Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57